Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Naviraí
1.ª Vara Cível

SENTENÇA

Vistos e examinados estes autos sob nº 0803332-39.2023.8.12.0029 de **AÇÃO Procedimento Comum Cível** em que é **Autor:** Ana Heloisy de Medeiros Loureiro e **Réu:** Estado de Mato Grosso do Sul e outro

Ana Heloisy de Medeiros Loureiro, representada por sua genitora Andréia Beltrão de Medeiros, qualificada nos autos, move a presente **Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Satisfativa** em desfavor do **Município de Naviraí** e do **Estado de Mato Grosso do Sul,** também qualificados, dizendo, em resumo, que tem 16 anos de idade e possui diagnóstico de diabetes do tipo 1, necessitado fazer uso de insulinas, dentre elas a Insulina Humalog 100ui/ml. Afirma que não possui condições de arcar com o custo, bem como não conseguiu obter o medicamento na rede pública de saúde, não lhe restando outra saída senão o ajuizamento da presente ação. Com base em tais fatos sucintos, objetiva a condenação dos Requeridos para que lhe forneçam a **Insulina Humalog 100ui/ml**, de forma contínua e pelo tempo de que necessite para seu tratamento. Apresentou outros requerimentos. Instruiu a inicial com os documentos de fls. 12/27.

Parecer favorável do Núcleo de Apoio Técnico às fls. 31/44.

Tutela de urgência indeferida (fls. 54/57) e, posteriormente, reformada em sede recursal.

O Requerido Estado de Mato Grosso do Sul na contestação ofertada, às fls. 71/82, discorreu pela necessidade de inclusão da União no polo passivo, a qual detém responsabilidade pelo fornecimento de medicamento não incorporado nos protocolos do SUS e no mérito pleiteou pela aplicação da tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ (TEMA 106).

O Requerido Município de Naviraí em sua defesa alegou, em suma, que o medicamento pleiteado não faz parte da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, de modo que deve ser observado para o seu fornecimento os requisitos estabelecidos pelo STJ no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (fls. 83/94).

A parte autora apresentou impugnação à contestação, oportunidade em que postulou pelo julgamento antecipado do feito (fls. 127/135).

Na fase de especificação de provas, os Requeridos disseram não possuir provas para produção (fls. 145 e 146).

Às fls. 112/116 foi juntado ofício referente ao Agravo de Instrumento n. 1407047-93.2024.8.12.0000.

É o relatório no essencial.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 30/10/2024 às 16:23 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803332-39.2023.8.12.0029 e código kFM3jAhl.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Naviraí
1.ª Vara Cível

Decido.

Inclusão da União e Competência da Justiça Federal

O Estado de Mato Grosso do Sul pede a inclusão da União no polo passivo desta ação, afirmando que, de acordo com a tese firmada pelo STF sob o tema 793, há a necessidade de o juízo direcionar o cumprimento da obrigação a um dos entes federados demandados. No caso, por se tratar de medicamento não padronizado, a obrigação seria da União.

A questão é objeto do Tema 1234 no STF, ainda não julgado:

> *Tema 1234 - Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.*

A questão será decidida com repercussão geral no recurso representativo da controvérsia RE 1366243.

Enquanto não realizado o julgamento, o STF determinou que sejam observadas as orientações do STJ no IAC n. 14. Conforme informações obtidas em "precedentes qualificados" no site do STJ:

> "**Em 19/4/2023 o Tribunal Pleno do STF**, referendou decisão liminar proferida em 17/4/2023 no RE 1366243 (Tema de RG 1234), relator Ministro Gilmar Mendes, na qual foi condedido parcialmente pedido formulado em tutela provisória incidental no referido recurso extraordinário para estabelecer que, **'até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros:** (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) **nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados**: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário'." - negritei

Desse modo, tratando-se de pedido de medicação não incorporada no SUS e de demanda ainda não sentenciada, deve ser mantida a tramitação perante a Justiça Estadual, opção eleita pela parte autora, sem inclusão da União, nem deslocamento de competência, aguardando-se a definição da questão no Tema 1234 do STF.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 30/10/2024 às 16:23 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803332-39.2023.8.12.0029 e código kFM3jAhl.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Naviraí
1.ª Vara Cível

Mérito

Conheço diretamente do pedido, nos termos do art. 355, I, do Novo Código de Processo Civil, pois desnecessária a produção de outras provas, o que, aliás, não foi requerido por nenhuma das partes.

O ordenamento jurídico brasileiro tutela o direito à saúde, determinando o artigo 196 da Constituição Federal que:

> "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Por sua vez, a Lei n.º 8.080, de 19/9/90, que trata das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, estatui em seu artigo 2.º quec *"A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício"*. E, no artigo 7.º, que:

> "As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde − SUS, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: I − universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; II − integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; IX − descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo: a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;".

Basta o dispositivo previsto no texto constitucional citado para se chegar à conclusão de que se deve garantir o direito de todos, <u>independentemente da condição financeira,</u> à saúde. As normas infraconstitucionais, que procuram dar efeito integrador ao texto constitucional, seriam até desnecessárias se existisse a consciência, por parte de todos os responsáveis pelas administrações dos entes federados, de que a Constituição Federal não é puramente analítica. A Constituição, com sua força normativa, constitui energia que deve influir na realidade. O dever da Administração de adquirir o necessário ao atendimento de pessoas doentes, imposto pela Constituição, não pode ser inviabilizado por entraves burocráticos e questiúnculas referentes à competência deste ou daquele órgão para distribuição. A distribuição de competências entre os entes federados é firmada para melhor servir aos cidadãos e não para aumentar seus sofrimentos e angústias, motivo pelo qual há solidariedade entre eles.

A edição da Lei nº 12.401/2011, em que pese sua importância e necessidade de respeito, não pode implicar em preterimento dos direitos do cidadão. A lei deve respeito à Constituição Federal e o Poder Judiciário é o garante das promessas do constituinte. Assim, como a Carta Magna traz a promessa de ampla proteção no campo da saúde, não pode o ente público se esquivar da sua obrigação, até porque estamos diante de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 30/10/2024 às 16:23 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803332-39.2023.8.12.0029 e código kFM3jAhl.

tema que perpassa pela dignidade da pessoa humana. O Tribunal de Justiça do Estado, a respeito do tema já decidiu:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 12.401/2011 – PREVISÃO CONSTITUCIONAL QUE PREVALECE SOBRE LEI, PORTARIA OU ATO NORMATIVO INFERIOR – DIREITO À SAÚDE – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR – PERIGO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – MEDICAMENTO EXPERIMENTAL – SEM RELEVÂNCIA DESDE QUE INDICADO POR MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE – RECURSO IMPROVIDO. Não há que se falar no reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei n. 12.401/2011, posto que já é pacífico o entendimento de que a garantia ao acesso igualitário das pessoas saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal está acima de qualquer lei, portaria ou ato normativo inferior. Uma vez sopesados os interesses de ambas as partes, verifica-se que o princípio da integralidade que é fundamento do interesse do recorrente, não deve prevalecer sobre o princípio basilar da pretensão do recorrido, que é o da dignidade da pessoa humana. Diante da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, como a prova inequívoca do direito e a verossimilhança das alegações acerca da necessidade do medicamento pleiteado, a decisão a quo deve ser mantida. Já é sedimentado o entendimento de que, se beneficiar o paciente, o médico pode utilizar um medicamento para finalidades diversas das indicadas, mesmo que em fase experimental. (TJMS, Quarta Câmara Cível, relator Desembargador Claudionor Miguel Abss Duarte, agravo nº 2012.015841-8, julgado em 17.07.2012).*

Desse modo, é patente a responsabilidade dos réus quanto ao atendimento das demandas relacionadas à saúde, o que, de resto, ficou assentado pelo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 793, que estabeleceu a seguinte tese:

> Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, **compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento** conforme as regras de repartição de competências **e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro**. (Grifei)

Portanto, os requeridos não podem se esquivar do cumprimento da obrigação, embora caiba ao juiz estabelecer, caso a caso, qual ente federativo deverá cumpri-la com prioridade.

Demonstrada a responsabilidade dos requeridos, verifico que, no caso, a parte autora demonstrou que possui uma demanda na área da saúde e que não conseguiu dos requeridos, administrativamente, o medicamento de que necessita.

Importa destacar, outrossim, que para os medicamentos pleiteados e que não estão padronizados pelo SUS, em razão da tese fixada pelo STJ no julgamento do Resp 1.657.156, deverá ser demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários ao fornecimento dos medicamentos pelo ente público:

> *a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia, dos fármacos*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 30/10/2024 às 16:23 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803332-39.2023.8.12.0029 e código kFM3jAhl.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Naviraí
1.ª Vara Cível

fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira do autor de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanatária – ANVISA.

Neste passo, apesar de indeferido o fornecimento da Insulina Humalog 100ui/ml em sede de tutela antecipada, verifico, em segunda análise, que os requisitos exigidos pelo REsp 1.657.156 (TEMA 106), encontram-se devidamente preenchidos:

Os dois últimos requisitos exigidos pelo REsp em comento são de fácil constatação, pois denota-se que os remédios pretendidos possuem registro na ANVISA (fls. 41, item IV) e que aparte Requerente se trata de pessoa hipossuficiente, já que se encontra assistida pela Defensoria Pública local, e afirma tal condição às fls. 12.

Com relação ao primeiro requisito *"Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da **imprescindibilidade** ou necessidade do medicamento, assim como da **ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS***"", está devidamente demonstrado nos autos por meio do laudo médico de fls. 16 e 18, cabendo destacar os seguintes trechos do referido documento médico que levam a tal conclusão:

LAUDO MEDICO

PACIENTE: ANA HELOISY DE MEDEIROS LOUREIRO

A paciente acima supracitada, de 16 anos é portadora de Diabetes tipo I insulino dependente, DE DIFICIL CONTROLE COM MEDICACOES OFERICIDAS PELO SUS, ATUALMENTE EM USO DE HUMALOG.

SOLICITO A MEDICAÇÃO DE USO CONTINUO PARA MELHORA DA RESPOSTA RENAL E GLICEMICA, EVITANDO PREJUIZO A SAÚDE DO PACIENTE CITADO.

A FALTA DESTE MEDICAMENTO PODERA LEVAR A GRAVES CONSEQUENCIAS DE COMPLICAÇÕES DA DIABETES TIPO I COMO A CETOACIDOSE DIABÉTICA, PODENDO CHEGAR A ÓBITO.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 30/10/2024 às 16:23 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803332-39.2023.8.12.0029 e código kFM3jAhl.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Naviraí
1.ª Vara Cível

A paciente acima supracitada, de 16 anos é portadora de Diabetes tipo 1 insulinodependente, DE DIFICIL CONTROLE COM MEDICACOES OFERICIDAS PELO SUS.

FOI PRESCRITO PELO COLEGA DR JUNIOR LIMA BEZERRA CRM MS 8540 - INSULINA LANTUS 100 ui/ ML APLICAR 40 UNIDADES SC 1X AO DIA NSULINA HUMALOG 100ui/ML APLICAR CONFORME ESQUEMA GLIFAGE XR 500MG TOMAR 1 CP APOS ALMOÇO APOS JANTAR ESTE MEDICAMENTO NÃO PODE SER SUBISTUIDO POR SIMILAR, VISTO SEU MECANISMO DE AÇÃO UNICO.

PACIENTE REFERE A MIM, MÉDICA RESPONSAVEL PELA ÁREA ADSCRITA, PSF SÃO PEDRO , NÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO E MANTER SEU USO POR LONGO PERIODO, SENDO ESTA UMA QUESTÃO SOCIAL IDENTIFICADA E ESTANDO O SISTEMA UNICO DE SAÚDE RESPONSAVEL, SOLICITO A MEDICAÇÃO DE USO CONTINUO ,PARA MELHORA DA RESPOSTA RENAL E DA GLICEMIA .

EVITANDO PREJUIZO A SAÚDE DO PACIENTE CITADO. POIS A FALTA DESTES MEDICAMENTOS PODERÁ TER GRAVES CONSEQUENCIAS DE COMPLICAÇÕES DA DIABETES TIPO I COMO A CETOACIDOSE DIABÊTICA , PODENDO CHEGAR A ÓBITO.

Portanto, demonstrada a impossibilidade de utilização de outras insulinas disponibilizadas pelo SUS pela requerente, tem-se que procedência do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, **JULGO PROCEDENTE** o pedido que **Ana Heloisy de Medeiros Loureiro** fez em desfavor do **Município de Naviraí** e do **Estado de Mato Grosso do Sul**, qualificados, para o fim de determinar aos réus que forneçam por meio de seus órgãos executores competentes, à parte autora a **Insulina Humalog 100ui/ml** durante todo o tratamento, na quantidade que for solicitada para tanto pelo médico que a acompanha, mediante receituário, no prazo de **20 (vinte) dias** após a solicitação, sob pena de sequestro de verba pública necessária ao cumprimento da obrigação.

Por oportuno, **DIRECIONO** o cumprimento da obrigação supra ao Estado de Mato Grosso do Sul, pois a distribuição dos medicamentos dentro do PCDT Diabete Melito Tipo 1 é de responsabilidade do Estado por meio do CEAF (fls. 42, item VIII), sendo o referido ente público responsável pelo atendimento, o que faço em vista das premissas estabelecidas pelo STF no Tema 793 e, no caso de custeio desta obrigação pelo Município, seja garantido o direito ao ressarcimento, administrativamente ou em ação própria. No entanto, resta mantida a solidariedade entre os entes públicos demandados.

Sem custas, *ex vi legis*.

Em vista do que restou decidido no Tema n. 1.002 do STF[1], condeno os Requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, que fixo em R$800,00 (oitocentos reais), com fulcro no art. 85, §8º do Código de Processo Civil, já considerado o grau de zelo do profissional, a importância e a

[1] O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002, fixou tese vinculante no sentido de que "é devido o pagamento de *honorários* sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra."

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 30/10/2024 às 16:23 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803332-39.2023.8.12.0029 e código kFM3jAhl.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Naviraí
1.ª Vara Cível

natureza da causa, o tempo e o lugar da prestação do serviço. Ainda, com fulcro no art. 87, § 1º, do CPC, determino a distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais em 50% entre os litisconsortes passivos, ou seja, cada Requerido deverá arcar com a metade dos honorários fixados.

Sentença sujeita a reexame, pois não é certo o valor da condenação, nos termos do art. 496, § 3º, do CPC e Súmula 490 do STJ.

Assim, decorrido o prazo recursal, mesmo sem oposição de recurso pelas partes, remetam-se os autos ao E. TJMS para reexame.

Havendo o trânsito em julgado, arquive-se com as formalidades.

P.R.I.C.

Naviraí/MS, datado e assinado digitalmente.

Eduardo Magrinelli Júnior
Juiz de Direito

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 30/10/2024 às 16:23 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803332-39.2023.8.12.0029 e código kFM3jAhl.